

إِسْمُ الْمَرِيضِ رِبَاعِيًّا : دَعَاءُ شَاذِلِي أَحْمَد خَلِيل

الحي / المدينة : حدائق القبه

المحافظة : القاهرة

رقم البطاقة : 27705150101102 رقم التليفون : 01116060671

العمر (تاريخ الميلاد) : 15-05-1977 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)

المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام ماموجرام وسونار علي الثديين [10888] **قسم العلاج :** الاورام

التعليق على التشخيص :-----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد کیلانی

الاسم: د/ندی حسن

الاسم: د/نرمين رمضان

الوظيفة: ----- التوقيع:

الوظيفة: _____ التوقيع:

الوظيفة: ----- التوقيع:

تتعمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير
المستشفى.

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.

كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

----- / د ----- / د ----- / د. | ----- / د. |

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

جهة العلاج : --

ملاحظات : ---

قسم :

تَفَقَّات :

ختم

شعار الجمهورية

مدير عام

مديرية الشؤون الصحية

رئیس

المجلس الطبي المتخصص

--

Name: دعاء شاذلي احمد خليل National ID: 27705150101102	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Bilateral mammogram and breast ultrasound
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة هوية شخصية



دعاء
ثماني أحمد خليل
٦٦ سن ترعة الجندون
حدائق القبة - القاهرة

١٩٧٧/٠٥

٢٧٧.٥١٥.١.١١.٠٢

LX7442717

١١١٦.٦.٧٧

١١/٥٤١٠٠٩٨

عيلة
٩١٩



٢٠٢٢/٠٨ ٢٧٧.٥١٥.١.١١.٠٢

ربة منزل

السن

مستلمة

أثني



البطاقة مصرية حتى ٢٠٢٢/٠٨/٢٢





Patient Name: Doaa shazly aluned	Patient ID: q10113496
Study Date: 9/1/2026	Modality Name: US
Report Date: 9/1/2026 1:54:23 PM	Sex: O

CT= mGy.cm || X-ray = mGy.cm.

SONO-MAMMOGRAPHIC EXAMINATION OF Rt. BREAST & BOTH AXILLA

FINDINGS:

- Scattered fibro-glandular breast parenchyma (ACR B).
- Right breast upper outer region shows rounded shaped density with partially obscured margin with irregular speculated margins and overlying scattered foci of microcalcifications, **complementary US** shows heterogenous hypoechoic lesion with areas of cystic degeneration internal foci of calcification & internal vascularity measures about 4.8x5cm x 4cm located opposite 9 to 11 o'clock position.
- The lesion shows intraductal extension with distance from nipple about 3cm with distance from skin ranging from 2-7mm
- Left breast shows multiple distended vascular density with us correlation shows multiple dilated veins most evident at the upper & lower outer quadrants yet compressible with normal flow no areas of architecture distortion or definite masses seen.
- Both axillae show multiple enlarged lymph nodes, oval shaped with preserved hilae,

IMPRESSION:-

- Right upper outer region highly suspicious lesion with suspicious ductal extension for biopsy and histopathological correlation (BI-RADS IV c).
- Left breast engorged veins with no evidence of superficial thrombophlebitis as above described for clinical correlation .

Much obliged,
Dr.sara anter,MD

Breast Imaging Reporting And Data System (BI-RADS)

Your category is shaded below in gray. The rest of the table is only for your information.

	Recommendation	Usefulness of course
0 (Needs further imaging study)	Recall for additional imaging	
1 (Negative)	Routine screening	Essentially 0%
2 (Benign)	Routine screening	Essentially 0%
3 (Probably benign)	Short interval follow up	>0% but <2%
4 (Suspicious)	Tissue diagnosis	• 4a Low suspicion for malignancy (>2% to <10%) • 4b Moderate suspicion for malignancy (>10% to <50%) • 4c High suspicion for malignancy (>50% to <95%)
5 (Highly suggestive of malignancy)	Tissue diagnosis	>95%
6 (Known, biopsy-proven)	Surgical excision when clinical appropriate	

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION



الهيئة العامة للتأمين الصحي
الإدارة المركزية لتنظيم المعلومات والتحول
الرقمي

رسوم الاستعلام 20 جنيه

تاريخ الإصدار: 2026-9-8

جهة الإصدار: فرع القاهرة

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للالتحاق الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والأزامل" وكذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس وقانون رقم 86 لسنة 2012 "الأطفال دون السن العشرية" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعية
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعي
وانبحث تبين أن

السيد (s) دعاء شاذلي احمد خليل بطاقة رقم 27705150101102
تليفون رقم: 01000000000

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الالتحاق
بمخبر من الفئات غير المستفعة بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون اننى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعة: 2026-9-8

الموظف المختص

ندى نصر الدين

أفادة مركز نظم المعلومات
يتمدد...



معمل 2072199

الخطاب ساري لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ الإصدار الا في حالة تغيير حالة المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية او
وزارة التضامن الاجتماعي او وزارة التربية والتعليم

الإدارة المركزية لتنظيم المعلومات والتحول الرقمي

جمهورية مصر العربية
بشارة النخيل المحمية

دعاء
شاذلي احمد خليل
١٦ ش بركة الجندی
حدائق القبة - القاهرة

١٩٧٧/٠٥
٢٧٧٠٥١٥٠١٠١١٢

LX7442717





٢٠٢٦/٠٨ ٢٧٧,٥١٥,٠١١,٠٢

ربة منزل

أنسنة

مصلحة

إتقى

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٣/٠٨/٢٢



١



StationID - Back
[DOCTYPE:ID_BACK]



NHTMRI

قسم الباثولوجي

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي
والأمراض المعدية

PATHOLOGY DEPARTMENT HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: دعاء شاذلي احمد خليل	Age: 49 years	Sex: female
Request type: مبادره	Sub request type:	
Hospital no:	Pathology no.:957B-2026	
Department: صحه مرأه	Date of result:19/9/2026	
Referred by: د/شريهان	Date of biopsy:9/9/2026	
Nature of specimen: tru-cut biopsy	I.D. Number:27705150101102	

Clinical diagnosis: Right breast mass

Gross pathology :

Multiple grayish white tissue cores up to 1cm long, totally submitted.

Immunohistochemical Technique

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against: ER- PR- Her2- KI67

Microscopic picture: Section examined revealed core of mammary tissue showing mucinous carcinoma. Tumor forms clusters strips and cribriform structures with low nuclear grade floating in pools of extracellular mucin with moderate lymphocytic response. Mucin pools are separated by fibrous septa with capillaries.

Immunohistochemical Result;

ER: Strong nuclear staining in 90% of tumor cells (Allred Score 8/8).

PR: Moderate nuclear staining in 40% of tumor cells (Allred Score 6/8).

Her2: Weak incomplete membranous staining in > 10% of tumor cells (score1+)low.

Ki67: Positive nuclear staining of 25% of tumor cells

Diagnosis: Right breast mass, tru-cut biopsy:

Provisional mammary core biopsy of Mucinous carcinoma, Grade I

Signature:

Dr.Mona Mohamed.M.D

Pathology Lab. Manager

BASMA REFAAT M.D



Patient Name: Doaa shazly ahmed	Patient ID: q10113496
Study Date: 9/1/2026	Modality Name: US
Report Date: 9/1/2026 1:54:23 PM	Sex: O

CT= mGy.cm || X-ray = mGy.cm.

SONO-MAMMOGRAPHIC EXAMINATION OF Rt. BREAST & BOTH AXILLA

FINDINGS:

- Scattered fibro-glandular breast parenchyma (ACR B).
- Right breast upper outer region shows rounded shaped density with partially obscured margin with irregular speculated margins and overlying scattered foci of microcalcifications, complementary US shows heterogenous hypoechoic lesion with areas of cystic degeneration internal foci of calcification & internal vascularity measures about 4.8x5cm x 4cm located opposite 9 to 11 o'clock position.
- The lesion shows intraductal extension with distance from nipple about 3cm with distance from skin ranging from 2-7mm
- Left breast shows multiple distended vascular density with us correlation shows multiple dilated veins most evident at the upper & lower outer quadrants yet compressible with normal flow no areas of architecture distortion or definite masses seen.
- Both axillae show multiple enlarged lymph nodes, oval shaped with preserved hilae,

IMPRESSION:-

- Right upper outer region highly suspicious lesion with suspicious ductal extension for biopsy and histopathological correlation (BI-RADS IV c).
- Left breast engorged veins with no evidence of superficial thrombophlebitis as above described for clinical correlation .

Much obliged,
Dr.sara anter,MD

Breast Imaging Reporting And Data System (BI-RADS)

Your category is shaded below in gray. The rest of the table is only for your information.

Category	Recommendation	Percentage
0 (Needs further imaging study)	Recall for additional imaging	
1 (Negative)	Routine screening	Essentially 0%
2 (Benign)	Routine screening	Essentially 0%
3 (Probably Benign)	Short interval follow up	>0% but <2%
4 (Suspicious)	Tissue diagnosis	4a Low suspicion for malignancy (>2% to <10%) 4b Moderate suspicion for malignancy (>10% to <50%) 4c High suspicion for malignancy (>50% to <95%)
5 (Highly suggestive of malignancy)	Tissue diagnosis	>95%
6 (Known, biopsy-proven)	Surgical excision when clinical appropriate	

تعرفني على كيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي

الخطوة الرابعة (على السرير)

- استلقي على السرير، استخدم يدي اليسرى لفحص الثدي الأيمن واليد اليمنى لفحص الثدي الأيسر.
- باستخدام أطراف أصابعك ومن خلال حركة دائرية، قومي بفحص الثدي (الجلد والأنسجة).
- تأكدي من فحص الثدي بالكامل من أعلى إلى أسفل، ومن جانب إلى جانب - من عظمة الترقوة إلى أعلى بطنك، ومن الإبط إلى منتصف الصدر.
- حتى تتأكدي من فحص الثدي بالكامل، يمكنك أن تبدئي من الحلمة ثم تتحركي في دوائر أكبر وأكبر حتى تصل إلى المنطقة الخارجية للثدي.
- يمكنك أيضاً تحريك أصابعك لأعلى ولأسفل رأسياً.

- لاحظي الإحساس بأي من العلامات التالية:

الشعور بأورام بالإبط الشعور بسمك عام

ورم محسوس

ألم بالثدي

الخطوة الخامسة (أثناء الاستحمام)

- اميدي الفحص السابق بنفس الطريقة المذكورة أثناء الإستحمام والجلد مبتل.

الخطوة الأولى (أمام المرأة)

- انظري إلى الثديين في المرأة مع وضع اليدين في وضع مستقيم على الجانبين ثم وضع اليدين على الوسط.
- تأكدي بالنظر إلى شكل ولون وحجم الثديين، وأنه هو المعتاد بالنسبة لكي دون تغيير أو دون اختلاف بين الثديين.
- لاحظي وجود أي من العلامات التالية بأي من الثديين :

طفح

حدوث تورم

تغير في الشكل أو الحجم

بروز الأوردة

تراجع أو تغيير في تفرحات بالجلد

تراجع أو تغيير في اتجاه الحلمة

الإحمرار

تحول الجلد لما يشبه قشر البرتقال

تجاعيد بالجلد

الخطوة الثانية (أمام المرأة)

- ارفعي يديكي إلى أعلى وتأكدي من عدم وجود أي من التغيرات السابقة

الخطوة الثالثة (أمام المرأة)

- أثناء رفع يديكي إلى أعلى، لاحظي خروج أي إفرازات غير طبيعية أو دم من الحلمتين اليمنى أو اليسرى

إفرازات غير طبيعية أو دم

- أمطلي، تمهين لتقومين بالمحصى الذاتي للثدي بعد آخر يوم في الدورة الشهرية أو من حالة إنقطاع الدورة الشهرية حدي يوم ثابت شهرياً لإجراء الفحص.

تتحدث حالة واحدة من العلامات السابقة نهجتي، إلى عيادة صحتك المرأة بتأهولة الممرضة

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



دعاء

شاذلي احمد خليل

٦٦ ش ترعة الجندی

حدائق القبة - القاهرة

١٩٩٧/٠٥



٢٧٧.٥١٥.١.١١.٢

LX7442717



٢٠٢٦/٠٨ ٢٧٧.٥١٥.١٠١١.٢

ربة منزل

أنثى

مسلمة

أنثى



البطاقة سارية حتى ٢٠٢٣/٠٨/٢٢

١





N H T M R I

قسم الباثولوجى

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
المعهد القومى للكبد والجهاز الهضمي
والأمراض المعدية

PATHOLOGY DEPARTMENT HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: دعاء شاذلي احمد خليل Age: 49 years Sex: female
Request type: مبادره Sub request type:
Hospital no: Pathology no.:957B-2026
Department: صحة مرآه Date of result:19/9/2026
Referred by: د/شريهان Date of biopsy:9/9/2026
Nature of specimen: tru-cut biopsy I.D. Number:27705150101102

Clinical diagnosis: Right breast mass

Gross pathology :

Multiple grayish white tissue cores up to 1cm long, totally submitted.

Immunohistochemical Technique

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against: ER- PR- Her2- KI67

Microscopic picture:. Section examined revealed core of mammary tissue showing mucinous carcinoma. Tumor forms clusters strips and cribriform structures with low nuclear grade floating in pools of extracellular mucin with moderate lymphocytic response. Mucin pools are separated by fibrous septa with capillaries.

Immunohistochemical Result;

ER: Strong nuclear staining in 90% of tumor cells (Allred Score 8/8).

PR: Moderate nuclear staining in 40% of tumor cells (Allred Score 6/8).

Her2: Weak incomplete membranous staining in > 10% of tumor cells (score1+)low.
Ki67: Positive nuclear staining of 25% of tumor cells

Diagnosis: Right breast mass, tru-cut biopsy:

Provisional mammary core biopsy of Mucinous carcinoma, Grade I

Signature:

Dr.Mona Mohamed.M.D

Pathology Lab. Manager

BASMA REFAAT M.D

Patient Name: Doaa shazly ahmed	Patient ID: q10113496
Study Date: 9/1/2026	Modality Name: US
Report Date: 9/1/2026 1:54:23 PM	Sex: O

CT= mGy.cm II X-ray = mGy.cm.

SONO-MAMOGRAPHIC EXAMINATION OF Rt. BREAST & BOTH AXILLA

FINDINGS:

- Scattered fibro-glandular breast parenchyma (ACR B).
- Right breast upper outer region shows rounded shaped density with partially obscured margin with irregular speculated margins and overlying scattered foci of microcalcifications, complementary US shows heterogeneous hypoechoic lesion with areas of cystic degeneration internal foci of calcification & internal vascularity measures about 4.8x5cm x 4cm located opposite 9 to 11 o'clock position.
- The lesion shows intraductal extension with distance from nipple about 3cm with distance from skin ranging from 2-7mm
- Left breast shows multiple distended vascular density with us correlation shows multiple dilated veins most evident at the upper & lower outed quadrants yet compressible with normal flow no areas of architecture distortion or definite masses seen.
- Both axillae show multiple enlarged lymph nodes, oval shaped with preserved hilae,

IMPRESSION:-

- Right upper outer region highly suspicious lesion with suspicious ductal extension for biopsy and histopathological correlation (BI-RADS IV c).
- Left breast engorged veins with no evidence of superficial thrombophlebitis as above described for clinical correlation .

Much obliged,
Dr.sara anter,MD

Breast Imaging Reporting And Data System (BI-RADS)

Your category is shaded below in gray. The rest of the table is only for your information.

	Recall for additional imaging	
0(Needs further imaging study)	Routine screening	Essentially 0%
1(Negative)	Routine screening	Essentially 0%
2(Benign)	Short interval follow up	>0% but <2%
3(Probably Benign)	Tissue diagnosis	4a Low suspicion for malignancy (>2%to <10%) 4b Moderate suspicion for malignancy (>10% to <50%) 4c High suspicion for malignancy (>50%to <95%)
4(Suspicious)	Tissue diagnosis	>95%
5(Highly suggestive of malignancy)	Surgical excision when clinical appropriate	
6(Known, biopsy-proven)		

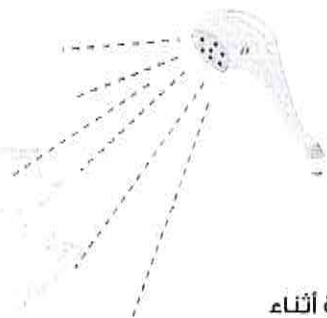
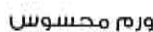
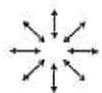
تُعرفني على كيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي

الخطوة الأولى (أمام المرأة)

- انظري إلى الثديين في المرأة مع وضع اليدين في وضع مستقيم على الجانبين ثم وضع اليدين على الوسط.
- تأكدي بالنظر إلى شكل ولون وحجم الثديين، وأنه هو المعتاد بالنسبة لكي دون تغيير أو دون اختلاف بين الثديين.
- لاحظي وجود أي من العلامات التالية بأي من الثديين :

الخطوة الرابعة (على السرير)

- إستلقي على السرير، إستخدمي اليد اليسرى لفحص الثدي الأيمن واليد اليمنى لفحص الثدي الأيسر.
 - باستخدام أطراف أصابعك و من خلال حركة دائرية، قومي بفحص الثدي (الجلد والأنسجة).
 - تأكدي من فحص الثدي بالكامل من أعلى إلى أسفل، ومن جانب إلى جانب - من عظمة الترقوة إلى أعلى بطنك، ومن الإبط إلى منتصف الصدر.
 - حتى تتأكدي من فحص الثدي بالكامل، يمكنك أن تبداي من الحلمة ثم تتحركي في دوائر أكبر وأكبر حتى تصلين إلى المنطقة الخارجية للثدي.
 - يمكنك أيضاً تحريك أصابعك لأعلى ولأسفل رأسياً.
 - لاحظي الإحساس بأي من العلامات التالية:
- الشعور بأورام بالإبط الشعور بسمك عام



الخطوة الثانية (أمام المرأة)

- إرفعي يديكي إلى أعلى وتأكدي من عدم وجود أي من التغييرات السابقة

الخطوة الثالثة (أمام المرأة)

- إفرازات غير طبيعية أو دم من الحلمات اليمنى أو اليسرى
إفرازات غير طبيعية أو دم

الخطوة الخامسة (أثناء الإستحمام)

- أعيد فحص السابق بنفس الطريقة المذكورة أثناء الاستحمام والجلد مبتل.

